

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	乳癌 Breast Cancer				
編號	A31000-Q03-W-M04	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/16 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員能瞭解乳癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

乳癌好發部位為乳房的外上 1/4 處，內下方是最少發生的部位，其可原發於一個乳腺葉組織的上皮細胞內。而上皮細胞有基底膜圍繞，癌細胞仍局限在基底膜內，則稱為「原位癌」；如果癌細胞突破基底膜，侵犯到外圍的基質，則為「浸潤癌」。

（二）症狀

1. 腫塊：病人就醫時最常見的症狀，病人摸到的腫塊大都是無痛性，但有些人會有壓痛感；初期時可移動，中、末期則推不動，最常見的部位為乳房的外上方，約 3/4 的病人是在沐浴時或自我檢查時發現的。
2. 乳頭分泌物：大多與腫塊一起出現，呈現血色分泌物，常見於年齡較大病人。
3. 皮膚變化：皮膚凹陷或皺縮，兩側乳房呈現不對稱，如直接侵犯到皮膚時，會呈現橘子皮樣變化。
4. 乳頭變化：產生回縮、下陷和濕疹樣變化（脫屑、潰爛、缺乏彈性），如固定且無法翻出；乳頭下有結節。
5. 腋下淋巴結腫大：表示已經有轉移。常侵犯的淋巴結為腋下淋巴結、鎖骨上淋

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/16

巴結及內乳淋巴結。

6.發炎性乳癌：有少數病人會出現紅、腫、熱、痛等典型的發炎病徵。

(三) 常見檢查

- 1.身體檢查：乳房自我檢查(Breast Self Examination；BSE)，依順時鐘或逆時鐘方向由外到內及由內到外觸壓，可發現腫塊；另外雙手上舉可發現患乳固定不上移，可能有黏附於胸壁之情形，擠捏時表面凹陷。
- 2.乳房攝影術(Mammography)。
- 3.乳房超音波。
- 4.磁共振造影(MRI)。
- 4.細針抽吸的細胞學檢查和切片的組織學檢查。
- 5.實驗室檢查：癌胚胎抗原(carcinoembryonic antigen，CEA)以及 CA-153 又稱兩者為「腫瘤標記(tumor marker)」，可評估癌症腫瘤之狀況及病程進展。
- 6.骨骼掃描：可診斷癌細胞是否有轉移至骨頭。

(四) 常見治療

1. 荷爾蒙治療

依據病人切片組織裡雌性素接受器(estrogen receptor, ER)及黃體固酮接受器(progesterone receptor，PR)，做為荷爾蒙治療的效果及測定乳癌復發快慢之依據。如結果為陽性，則其荷爾蒙療效可達 70-80%；反之，病人的 ER 為陰性，大約只有 5-10%有效，故 ER 陰性的病人大多採用化學治療。在選擇荷爾蒙治療時，停經前的病人大部份會先考慮使用 Tamoxifen，除非 Tamoxifen 無效才會考慮後線藥物：

- (1)Tamoxifen：是一種非類固醇的抗雌性激素，其作用在競爭雌性素接受器，阻止雌性素對乳癌細胞的作用。其主要副作用包括臉部潮紅、子宮內膜增生及肝功能變化等，通常病人只要減少劑量或是停藥即可改善症狀。
- (2)aromatase inhibitors(AI)：停經後的婦女可以使用 Tamoxifen 或使用芳香酶抑制劑(aromatase inhibitors)。因停經婦女利用 aromatase 酵素把雄性素轉為雌

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/16

性素，而 aromatase inhibitors 可以阻斷 androstenedione（男烯二酮）變成 estrone 及 estradiol，造成雌性素濃度下降。臨床上常用的藥物為 anastrozole(Arimidex)、Letrozole(Femara)及 exemestane(Aromasin)。目前的證據指出停經後的婦女用 aromatase inhibitors(AI)比 Tamoxifen 的效果更好。

(3) megestrol：是一種合成的黃體素，主要是降低乳癌細胞荷爾蒙的數目，並改變動情激素對於這些細胞的作用，以直接對腫瘤細胞產生毒害作用。

(4) LH-RH agonist：一般使用在停經前荷爾蒙接受體陽性的轉移性乳癌病人。主要作用是抑制腦下垂體分泌黃體素(LH)及濾泡促進激素(FSH)，來降低女性血液裡的 Estradiol，使 estradiol 降為接近停經時的濃度。臨床上常用藥物為 leuprolide(Leuplin Depot)及 goserelin(Zoladex)。

(5) diethylstilbestrol(DES)：為一種合成的雌性素。停經後，或卵巢切除的病人有轉移性乳癌者，可能會使用高劑量的雌性素來治療乳癌，主要機轉目前不是很清楚，但臨床上有數據支持雌性素對於癌症細胞有直接抑制作用。因毒性很大，故大多以 Tamoxifen 來取代雌性素。作用在於轉移細胞漿雌性素接受器進入細胞核，促使腫瘤分化成熟而停止增生。其副作用為噁心、嘔吐、色素斑、水分滯留等。

(6) 腎上腺阻斷劑：對周邊組織可抑制男烯二酮(androstenedione)轉化為雌性素。其副作用為嗜睡、運動共濟失調、眼球顫動。

(7) 卵巢切除術：減少雌性素的產生，可使原發腫瘤變小及骨痛減輕。

(8) 腎上腺切除術：減少雌性素的產生，但須終生補充類固醇荷爾蒙。

(9) 腦下垂體切除術：作用在於減少 LH、FSH、ACTH 和 PRL 分泌，減少雌性素產生。手術後宜補充糖皮質固酮、礦皮質固酮及甲狀腺刺激素(TSH)。

2. 外科治療

手術切除是最常使用的治療方法，方法如下：

(1) 乳房保留手術(Breast Conserving Surgery, BCS)：只切除惡性腫瘤及其周圍

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/16

附近之乳房組織，保留大部分的胸大肌及乳房，術後仍須接受放射線治療。

(2)全乳房切除術(simple mastectomy total mastectomy)：切除全部乳房、胸肌膜以及腫瘤上方所覆蓋的皮膚，保留腋下淋巴結及胸大肌。

(3)改良性根除乳房切除術(modified radical mastectomy MRM)：切除整個乳房及腋下組織，保留胸大肌。因胸大肌保留可使肩胛和胸壁的輪廓得以保留，使鎖骨不致凹陷，手臂能保存力量且淋巴水腫得以減輕，乳房有重建的可能。

(4)根除性乳房切除術(radical mastectomy)：切除乳房及其皮膚、皮下組織、胸大肌及腋下淋巴結。

(5)廣泛性根除乳房切除術(extended radical mastectomy)：除了根除性的乳房切除術外，再加上內胸淋巴結切除。

(6)前哨淋巴結切除(sentinel lymph node resection)來取代腋下淋巴擴清手術(axillary lymph node dissection)，以減少手臂水腫及肩關節不適。若前哨淋巴結有腫瘤轉移時，則需施行腋下淋巴擴清手術。

3. 放射線治療

(1) 放射線治療，可減少局部的復發率和提高存活率。適應症包括有：

A.發炎型的乳癌、乳房皮膚水腫或腫瘤大於 5cm，不能局部手術者或腋下淋巴轉移數大於 3 個以上。

B. 接受乳癌手術病人。

(2) 放射線治療種類則有：

A.體外放射線治療：以鈷 60 治療機的伽瑪射線及直線加速器所產生高能量 X 光電子射束；做完後病人會有皮膚改變、喉嚨乾澀、肺基底部發生炎症的改變等副作用。

B. 組織間植入治療：此法病人須住院將銥 192 放入體內，存留 2-3 天；病人只能在房間內走動，其放射線防護措施仍須以時間、距離和使用的防護措施而定。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/16

4. 化學療法

針對治療惡化的乳癌，都採用 3-5 種藥物合併治療。但其副作用有噁心、嘔吐、骨髓受抑制、禿髮和倦怠。

5. 藥物治療

- (1) paclitaxel(Taxol)太平洋紫杉醇：抑制細胞有絲分裂，阻斷細胞於細胞週期的 G2 跟 M 期。

副作用：急性過敏性休克、過敏反應（低血壓、呼吸困難、蕁麻疹、潮紅及腹痛）、抑制造血細胞。

- (2) doxorubicin(Adriamycin)小紅莓：抑制 DNA、RNA 合成。

副作用：骨髓抑制（可逆性的白血球減少）、噁心、嘔吐、暫時性掉髮、血管刺激。

trastuzumab(Herceptin, Cetuximab)：為標靶藥物。當癌細胞上皮生長因子(Her-2)表現過度時，使用此藥以抑制癌細胞繁殖能力，但不破壞正常細胞。

副作用：噁心、嘔吐、發燒或骨頭酸痛。

- (3) cisplatin(Platinol)：為一種對細胞繁殖沒有特異性選擇的廣效性抗癌藥物，可阻斷 DNA 合成，阻斷癌細胞分裂。

副作用：腸胃反應（噁心、嘔吐、食慾不振）、骨髓抑制（中性白血球缺乏症、血小板缺乏症、貧血）、神經毒性（周邊神經炎、伴隨四肢感覺異常抽搐，以及味覺喪失）、過敏反應（臉部潮紅、水腫、呼吸哮鳴聲）。

- (4) CMF 治療(cyclophosphamide, methotrexate, 5-Fu)：cyclophosphamide 可分解體內細胞，抑制腫瘤的生長；methotrexate 類似葉酸的構造，可阻止核酸與 purin 合成對抗腫瘤；5-Fu 影響 DNA 的合成。

副作用：cyclophosphamide 引起噁心、嘔吐、食慾不振、膀胱黏膜損傷等；Methotrexate 引起口腔黏膜潰瘍、下痢、進行性貧血、出血等；5-Fu 引起口腔潰瘍、白血球降低、血小板減少、腸胃潰瘍等。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/16

(五) 護理問題

1. 尋求(特定的)健康協助/與手術前後知識不足有關。
2. 焦慮感受/須接受手術治療。
3. 易感染/手術。
4. 易感染/化學治療（放射線治療）。
5. 缺乏營養/化學治療、放射線治療。
6. 身體心像不一致/失去一邊乳房。

(六) 護理措施

1. 尋求(特定的)健康協助/與手術前後知識不足有關。
 - (1) 評估病人及家屬對手術的瞭解程度。
 - (2) 告知手術的目的、過程及可能造成身體心像的改變。
 - (3) 提供衛教單張並予指導、說明。
 - (4) 鼓勵病人發問及解答其疑問。
 - (5) 介紹成功病人，減輕其焦慮並給予心理支持。
 - (6) 配合完成手術前的各項準備及護理。
 - (7) 給予手術前指導，如告知開始禁食時間及禁食原因。
 - (8) 教導早期下床活動。
 - (9) 教導深呼吸、咳嗽、翻身運動。
 - (10) 衛教若有傷口感染及異常徵兆（紅、腫、熱、痛、滲液多、滲血）請通知護理人員。
2. 焦慮感受/須接受手術治療
 - (1) 評估病人焦慮程度及主要原因，運用傾聽並引導個案表達對治療的了解與疑惑及內心擔憂之事與感受。
 - (2) 請醫師解釋手術過程協助病人確認可能的壓力。
 - (3) 帶病人認識開刀房或恢復室環境，鼓勵病人說出感受。
 - (4) 指導病人手術後咳嗽或翻身時如何固定傷口，減少疼痛。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/16

- (5)讓病人瞭解手術後可能存在的引流管及其重要性，減少焦慮。
- (6)若病人焦慮是因怕手術後的疼痛，應給予解釋醫師會適時給予控制疼痛的處理。
- (7)利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕恐懼。
- (8)安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕恐懼，如聽音樂、聊天。
- (9)經常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (10)介紹相同的病人，彼此認識並交換心得。
- (11)請家屬陪伴並給予心理支持。
- (12)若恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。
- (13)引導病人參與自我照護。

3. 易感染/手術

- (1)監測生命徵象。
- (2)監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。
- (3)記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。
- (4)觀察傷口敷料外觀。
- (5)治療前後洗手。
- (6)無菌技術收集標本培養以監測感染存在。
- (7)依醫囑正確使用冰或熱敷。
- (8)依醫囑按時給予抗生素。
- (9)依醫囑以無菌技術換藥。
- (10)教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
- (11)教導感染的危險因子及預防感染的方法。
- (12)指導炎症症狀及徵象。
- (13)教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。
- (14)宣導抽菸、喝酒害處。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/16

4. 易感染/化學治療（放射線治療）

- (1) 監測生命徵象。
- (2) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。
- (3) 監測藥物副作用並衛教藥物注意事項及可能之副作用。
- (4) 監測輸液注射部位有無感染情形並教導維持輸液的通暢性。
- (5) 治療前後洗手。
- (6) 運用適當隔離技術，包括：口罩、手套或隔離衣。
- (7) 安置於隔離病房或個人房。
- (8) 限制訪客。
- (9) 避免侵入性治療，如有必要採無菌技術執行。
- (10) 依醫囑按時給予抗生素或抗癌藥物。
- (11) 教導感染的危險因子及預防感染的方法。
- (12) 指導炎症症狀及徵象。
- (13) 教導選擇高蛋白、高維生素飲食及相關疾病飲食衛教。

5. 缺乏營養/化學治療、放射線治療

- (1) 固定時間測量體重。
- (2) 依醫囑監測血液白蛋白檢驗值變化。
- (3) 計算病人每日所需攝取熱量及實際食物攝取熱量。
- (4) 評估有無消化不良、腹脹、腹瀉等情況。
- (5) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。
- (6) 採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。
- (7) 依醫囑供應每日所需的熱量（卡路里）。
- (8) 依醫囑每日供給適當的液體輸注。
- (9) 建議少量多餐以增加進食量。
- (10) 教導進食前給予口腔護理以增加味覺。
- (11) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物，若有腹脹則減少攝取產氣食物及

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/16

飲料。

(12)衛教營養狀況少於身體需要的症狀及徵象。

6. 身體心像不一致/失去一邊乳房

(1) 以主動傾聽、開放式問題，促進病人表達感受。

(2) 以不批判態度接受病人用憤怒來表達自己的挫折或感受。

(3) 若病人陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。

(4) 給予病人足夠的時間，做開始接觸患處的心理準備。

(5) 以溫和漸進方式，鼓勵病人去觸摸及正視乳房切除的部位。

(6) 多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，以取得病人信任。

(7) 當病人開始接受改變，應給予鼓勵。

(8) 在病人未接受前，指導病人穿寬鬆衣服，適當掩飾，暫時調適情緒。

(9) 鼓勵病人走出病房，多接觸其它人、事、物，找尋適當方法抒解情緒。

(10) 介紹相同病人，互相表達感受，彼此交換意見。

(11) 鼓勵病人習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。

(12) 指導並協助病人的親人（先生）接受病人，並常表達關懷，給予安全感。

(13) 若發現病人有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。

(14) 提供義乳穿戴的相關資訊或目錄，供病人參考。

(15) 鼓勵參加失去乳房婦女團體座談會，彼此取得心靈的安慰及支持。

(16) 鼓勵病人投入社會公益活動，拓展視野，找回自信心。

(17) 病人若有虔誠的宗教信仰，鼓勵可適當的應用，避免負向情緒的發展。

（七）衛教指導

1. 乳房切除術後須知

(1) 手術後

A. 手術後回到病房請先安靜臥床休息，在護理人員依醫囑指定時間拔除導

尿管後，即可下床活動如廁。

B. 教導病人正確的起床方法，由健側支撐身體坐起，以減少患臂受壓。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/16

- C. 若無特殊情況，請依醫護人員指導的時間在手術當天開始喝水→進食流質→軟質。
- D. 若感覺手術傷口疼痛難忍或發現傷口有出血滲液，請通知護理人員處理。
- E. 維持傷口引流管通暢，勿牽扯或扭曲。
- F. 以彈性繃帶保持傷口清潔乾燥，施予輕微壓力，以防止傷口出血。
- G. 在醫師診察換藥後若無特殊情況即可出院。

(2) 出院後注意事項

- A. 手術後兩天即可完全活動，沒有限制。
- B. 飲食以均衡飲食為主。
- C. 保持傷口清潔乾燥。
- D. 維持引流管通暢，勿牽扯或扭曲。
- E. 請依醫囑按時回醫院複診，手術後 7 至 10 天即可於門診拆線。

2. 傷口及引流管護理

- (1) 病人患側的手臂須以加壓繃帶包紮，來增加手術部位的壓力，避免患側手臂淋巴水腫。傷口置引流管來引流滲液和血液，以促進皮瓣和胸壁緊密貼合，避免血腫形成。
- (2) 注意引流管的排空及引流量，如果引流管出現栓塞、脫落、感染及出血情形，應報告醫師。
- (3) 當傷口更換敷料時，鼓勵病人注視傷口，第一次病人可能不願意看，勿強迫應尊重病人，待其逐漸接受後，可藉機教導病人回家後如何清潔傷口及觀察感染情形。
- (4) 指導病人皮膚經過放射線照射後可能發生的變化，如：鱗屑、脫皮、乾裂、癢、紅斑，並教導他們如何自我照顧：
 - A. 以溫和的肥皂和清水清洗照射部位、輕拍，並保持乾燥。
 - B. 避免塗擦乳液或乳霜，除非有醫囑。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/16

C. 盡量避免所穿的衣服摩擦到皮膚，不要穿胸罩。

D. 照射部位避免冷（冰敷）、熱（陽光、熱敷）的刺激。

3. 化學治療須知：抗癌藥物皆具細胞毒性，除了殺死癌細胞也會殺害正常細胞，故人體會產生許多副作用。

(1) 疲倦：要有充足的睡眠及休息、規律的生活及適當的運動。

(2) 皮膚發癢、脫皮乾燥：需注意皮膚的清潔、乾爽、勿抓癢、勿過度曝曬，若有藥物滲出血管外，需立即告訴護理人員。

(3) 白血球減少：養成良好的衛生習慣，避免出入公共場所，必要時戴口罩注意體溫的變化，避免食用生的食物，以煮熟食物為主。

(4) 血小板減少：避免劇烈運動、擦撞及受傷，避免使用阿斯匹靈類藥物，應使用軟毛牙刷，注意身上是否有不正常出血。

(5) 貧血：多攝取鐵質食物，如：綠色蔬菜、肝臟、葡萄乾、瘦肉，採漸進式活動以避免暈眩，多休息。

(6) 禿髮：洗頭、梳髮時動作要輕柔，用中性洗髮精，避免刺激頭皮，可帶假髮或帽子保持美觀。

(7) 口腔黏膜炎：常刷牙漱口保持口腔衛生，避免刺激性食物，採軟質、溫和的食物，必要時給予消炎、止痛藥漱口。

(8) 噁心、嘔吐：少量多餐，避免刺激性食物或過冷過熱食物，細嚼慢嚥，進食乾性食物，如：吐司、餅乾，用餐期間避免飲料，餐後不可平躺。

(9) 便秘：每天喝 3000cc 的水，吃高纖食物，如：蔬菜、水果，避免產氣食物，如：豆類、牛奶、碳酸飲料，適度的運動或服用軟便劑。

(10) 腹瀉：需多喝水防脫水，食用含鉀的食物，如蔬菜湯、橘子汁、柳丁汁、蕃茄汁、香蕉等（避免電解質不平衡），採清淡飲食，如：米湯、去油肉湯、果汁。

(11) 味覺改變：因化學治療會使味覺改變，故烹調時，可多採甜或酸的調味料，避免食用苦味重的食物，且可經常變更烹調方式以促進食慾。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	12/16

(12) 泌尿道方面：因藥物會傷害腎和膀胱，故每天至少需喝 2000cc 以上的水，避免咖啡、茶、酒，多注意尿液變化。

(13) 性事方面：治療期間應避免懷孕，以免造成畸胎，仍可有性關係，可多利用擁抱、愛撫來得到滿足。

(14) 神經、肌肉方面：可能會虛弱、變遲鈍、手腳麻木，應避免跌倒，可使用輔助器，如：拐杖、助行器來活動，需注意聽力是否有受損。

(15) 呼吸、循環方面：可能有胸悶、呼吸困難的情形，故宜緩慢改變姿勢，有充足的休息，若有不適，需告知醫護人員。

4. 手臂復健運動

(1) 鼓勵病人抬高手臂、做手臂運動，以促進淋巴引流和預防感染。

(2) 絕不可在患側測量血壓、注射及抽血，以防引起循環受損及感染。

(3) 告知病人患側應避免刀傷、抓傷、針刺傷、昆蟲咬傷、灼傷及使用強烈的清潔劑；避免使用患側手拿重物、戴手錶、接觸熱的鍋子、抽香菸、修剪花園的花木及挖泥土。以免造成嚴重的感染，使手臂水腫更厲害。

(4) 告知病人手術後做放射線照射，會增加手臂水腫的次數和嚴重度，並教導病人評估手臂感染的症狀及循環受損情形。

(5) 協助病人在麻醉清醒後做手、指頭、腕部的屈曲和伸張運動，待傷口癒合後才可做手臂的外展。

(6) 指導病人躺著或坐著時，手肘放在枕頭上使其高過肩部，但避免內收，以免造成腋下窄縮，引起不適。

(7) 鼓勵病人術後第二天用患側的手去執行自我照顧的活動，如：刷牙、梳頭、洗臉等，限制上臂的全範圍關節活動(ROM)，僅做抬高肩膀而已。

(8) 告知病人腋下引流管移除後約術後第 7 天，才可實施漸進式的上臂 ROM 活動：

A. 爬牆運動(hand wall climbing): 面對牆站著，腳趾盡量靠近牆，雙腳分開，肘彎曲，手掌貼在牆上與肩同高，手指彎曲漸往牆上方移動，直到手臂

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	13/16

完全伸展為止，然後手臂再往下移至原來位置。

B. 轉繩運動(rope turning)：面向門站立，繩子一端綁在門把上，另一端由患側抓住手臂伸展，與地面平行，然後以畫圈方式轉動繩子，慢慢加大圈圈大小。

C. 舉桿運動(rod or broom)：由兩手伸直握住桿子相距 0.6 公尺，再將桿子舉高過頭頂，彎曲肘部將桿子放在頭後方；反方向再將桿子抬高至頭頂，再回到原來位置。

D. 滑繩運動(Pulley)：用患側將 1.8 公尺長的繩子繞過橫桿，用雙手各抓繩子一端，健側手先將繩子往下拉，以使患側手逐漸抬高，一直高到感到不舒服為止。

5. 介紹義乳的種類，維持病人之身體心像

(1) 暫時性義乳最好選擇依地心引力及身體姿勢的變化而能改變形狀，並配合人體力學。

(2) 永久性義乳（隆乳）植入法：

A. 乳房重建時機最好由醫師來判斷，通常早期乳癌（第一、二期）可以立即重建，而晚期乳癌則考慮術後行放射線治療、化學治療，建議治療後再重建。

B. 矽膠質義乳植入法：將矽膠質義乳直接植入或植入保存的胸大肌或前鋸肌下，目前已少用。現在多採用植入矽質組織擴張袋於乳腺下或胸大肌下，再灌注生理食鹽水至袋內。

C. 背闊肌肌皮瓣轉位法：將肌皮瓣依照缺失乳房部位加以規劃，轉位後肌瓣上的皮瓣應位在預重建乳房的下方以支撐乳房的懸垂，且在肌肉下置放矽膠質義乳。

D. 橫位式腹直肌肌皮瓣：採用對側的腹直肌供給皮瓣，將可獲得較好的轉軸，做好後可在腹直肌下植入矽膠質義乳。

(3) 傾聽病人表達其對乳房失去之後的感受。

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	14/16

(4)建議病人接受病友之現身說法，讓病人有勇氣去克服手術的心理障礙或鼓勵病人參加乳房切除術後之婦女團體。

(5)鼓勵病人盡早回復正常生活，並從事原來的工作。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 胡月娟(2020)生殖系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（四八版，1009-1027 頁，下冊），華杏。
- (二) 賴思瑜、黃思緯、江淑娟、吳美娟、謝嘉琪(2019)．一位乳癌復發個案面臨死亡恐懼之案例報告．秀傳醫學雜誌，18(2)，137-146。
- (三) 蔡明霖(2021)．乳癌治療．台灣更年期醫學會會訊，65，17-19。
- (四) 中山醫學大學附設醫院乳癌多專科醫療團隊編修(2023)．乳癌診療指引，中山醫學大學附設醫院。

七、附件

(略)

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	15/16

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	(1).電腦斷層改核磁共振(MRI)。 (2).局部乳房切除(local excision)改乳房保留手術(Breast Conserving Surgery；BCS)。 (3).衛教指導部份修辭。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 增修第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第三項第四目之 3(2)B；第七目之 1、4 新增參考資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	乳癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M04	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	16/16

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	3.5	1. 第三項第一目內容修訂。 2. 第五、六目更新護理問題。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.6	1. 第三項第五、六目護理問題及護理措施內容修正。 2. 第六項參考資料更新。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.7	第六項參考資料更新。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.8	第六項參考資料更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。